

Fecha Última Actualización: 24-02-2023 0:22:17

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Georgina Isabel Galarce Reyes
Edad : 70a 10m 10d
Dirección : Las Lilas 6821

Rut : 6.222.583-1
Fecha Nacto: 13/04/1952
Comuna : La Granja

N° Archivo : 2301190
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 3355 6640

N° Epicrisis
341511

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 18/01/2023 00:44

Días Estadía : 36

Unidad de Egreso : Utac/ Utinx

Fecha Egreso : 23/02/2023 12:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Obs infarto cerebral

Comorbilidades

Insuficiencia Renal Crónica; Demencia; Hipertensión Arterial;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha ing CASR: 18-01-23
Fecha ing UCI: 18-01-23
Fecha ingreso UTAC 15-05-23

Pacien diestra, mRs 3 (no puede salir de su casa. Logra actividades en su domicilio como hacer cama, bañarse, vestirse) con los siguientes antecedentes:

Médicos:

- Insuficiencia Renal crónica etapa 3
- Demencia en estudio.

Quirúrgicos: colecistectomía

Fármacos: sertralina, enalapril suspendido

Alergias: no

Social: dependiente de ABVD de forma parcial.

ANAMNESIS

Derivada desde Hospital Padre Hurtado por cuadro de compromiso de conciencia. Familiar refiere que el mismo día de la consulta a las 10:00 inició dolor abdominal difuso asociado a 2 episodios de vómitos y que progresó a las 13 hrs con deterioro de conciencia. Se describe al ingreso HPH en Glasgow 9, pupilas isocóricas reactivas, hemiparesia braquiocrural derecha, movimientos clónicos hemicara derecha, automatismo de mano izquierda. TC de encefalo / AngioTC hematoma núcleo caudado izquierdo asociado a vaciamiento ventricular con hidrocefalia aguda. No se observan malformaciones vasculares ni dilataciones aneurismáticas asociadas.

Es derivada a CASR para resolución de hidrocefalia con hemoventrículo izquierdo. Se instaló DVE a 12 cm de CAE. Ingresa a Recuperación Anestésica el 18-01-23 en VMI con Fio2 40 %, bien adaptada, sedación con fentanyl/propofol, cargada de fenoína, cubierta con ATB cefazolina EV. Sin DVA.

Se decide traslado a UCI para manejo por especialidad.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO UPC

Hematoma intraparenquimatoso con vaciamiento ventricular

Hidrocefalia secundaria - DVE (18-01-23)

Fecha Epicrisis : 24/02/2023 00:22

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 24-02-2023 0:22:17

Página 2 de 5

Antecedentes: Insuficiencia Renal Crónica, demencia en estudio

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS EN UPC

Hemodinamia:

inicialmente tendiente a la hipotensión y taquicardia sinusal posiblemente en contexto de cuadro séptico, requirió NAD en dosis bajas para metas de PAM con buena perfusión. Sin DVA actualmente

Respiratorio:

VNI para protección vía aérea, no se intenta destete dado deterioro de conciencia severo a pesar de suspensión de sedación. Se realiza TQT 27/01 sin incidentes, con mejoría progresiva de conciencia, se difiere weaning dado cuadro séptico intercurrente, logra suspender soporte ventilatorio 72 hrs. A la fecha, ventilando espontáneamente, con buena mecánica y adecuada oxigenación.

Ventanas a filtro por TQT a tolerancia.

Infeccioso:

Desde el punto de vista infeccioso, cursa con KPN BLEE (+) x NAVM, completó 7 días de imipenem, pero dado aumento de parámetros inflamatorios y persistencia de fiebre se ajusta esquema antibiótico a Amika/Line y Colistin. Desde el punto de vista microbiológico, se informa a las 44 hrs de HC periféricos S. epidermidis con cambio de CVC. 28/01 UC (-), 27/01 CAET (-), 28/01 HC I y II (+) Staph capitis (MR) posible contaminación, cultivo LCR 31/01 (-). Considerando deterioro hemodinámico con aumento de soporte de DVA se decide ampliar cobertura ATB adicionando Meropenem en dosis meníngeas (FECHA). Sin microbiología aislada, se suspende colistin, se decide completar esquema antibiótico con 7 días con Mero/Vanco empírico. En contexto de estudio infeccioso se solicitó HTLV1 y HTLV2 que resultaron positivos, además de estudio de CMV.

Renal/M. Interno:

Desarrolló falla renal en contexto de Colistin y shock séptico. Con Crea en mejoría, sin urgencia dialítica. Mantener en seguimiento, evitar nefrotóxicos.

Neurológico

En seguimiento por equipo de Neuro por HIP putaminal izquierdo con vaciamiento ventricular, hidrocefalia aguda operada (18/01/23); y síndrome convulsivo transitorio que recibió tratamiento con fenitoína, pero dada estabilidad clínica, se decidió su suspensión el 28/01/23.

Neuroquirúrgico

En seguimiento por neurocirugía, DVE con débito adecuado, evaluado por neurocirugía el 13/02/23 se decide retiro de DVE, con TC control sin hidrocefalia. Sin conflicto actual.

Profilaxis: habituales

DIAGNÓSTICOS ACTUALES

Secuelas de hematoma intraparenquimatoso izquierdo hipertensivo con vaciamiento ventricular

Hidrocefalia 2ria en tratamiento con DVE (18/01/23)-DVE retirado

AKIKDIGO 3 en resolución sobre ERC

Sepsis sin foco claro - Meropenem/Vancomicina empíricos

NAVM por KPN BLEE tratada

Destete prolongado de la ventilación mecánica

Traqueostomía percutánea 27/01/2023

Antecedentes: Insuficiencia Renal crónica etapa. Demencia en estudio.

PLAN

Traslado a neurología básica para rehabilitación neurológica.

(Ingresa a UTAC por no disponibilidad de camas)

EVOLUCION UTAC

Paciente ingresa hemodinamicamente estable, con tendencia a la taquicardia sinusal, febril hasta 39°. Con traqueostomía in situ,

Fecha Epicrisis : 24/02/2023 00:22

Página 2 de 5

funcionante y sin signos de infección.

NEUROLOGICO

Neurologicamente logra conexión con examinador, no obedece ordenes de forma consistente, con plejía hemicuerpo derecho, moviliza hemicuerpo izquierdo hasta M4 braquial y M3 crural.

Sin requerimientos de oxígeno pero destaca con abundantes secreciones por boca.

En plan de continuar con neurorehabilitación, movilizándose en cama y alimentándose por SNG con Diben 40cc/h bien tolerado.

Continúa en seguimiento por kinesioterapia y fonoaudiología.

INFECCIOSO

A su ingreso a la unidad destacó t° hasta 39° , asociado a hipotensión con buena respuesta a volumen, interpretándose como descarga séptica, por lo que se decidió amplio estudio infeccioso, pesquisándose orina inflamatoria con GB 10-15 por campo. Pendiente urocultivo y hemocultivos. Se inició Amikacina 1g de forma empírica, con plan de ajuste según antibiograma. Se retiró PICC. El 18/2 con antibiograma se desescaló a Cefazolina sin embargo el 19/2 presentó nuevo peak febril, por lo que infectología ajustó a Ertapenem, completando tratamiento 23/02.

Se mantiene subfebril en control con parámetros inflamatorios de momento

Estudio:

- Rx de tórax 17/02 sin condensación ni derrame pleural.
- 19/2: Cultivo corriente negativo
- 18/2: HC PICC LINE: negativo
- 19/2: Aspirado TQT: sin bacterias
- 16/2: urocultivo (-), orina inflamatoria
- 15/2: HC cuantitativo (+) para *S. aureus* S a cloxa
- 15/2: Cultivo catéter (-). HC 1 y 2 (P)

RENAL

Cursó con insuficiencia renal en regresión, actualmente con crea en 0.99 y VFG 47ml/min, por lo que se mantiene conducto expectante. Actualmente sin necesidad de TRR. Actualmene Creatinina 1.13 (VFG 60ml/min). Cursando leve hipokalemia en tratamiento con aportes de ampollas de KCl vía oral.

Kinesioterapia: actualmente trabajando control de tronco al sedente borde cama. Pendiente progresar en estabilidad y control de tronco.

Fonoaudiología: se estimula con hielo, realiza movimientos orales y paradegluciones. Pendiente progresar en deglución. De momento con pobre pronóstico fonoaudiológico, de acuerdo a evolución en próximos días, considerar gastrostomía.

Se deriva para continuar neurorehabilitación. Al momento hemodinámicamente estable con un examen que destaca:

Vigil, no emite lenguaje (TQT), ni tiene intención comunicativa, logra seguimiento de examinador, no obedece órdenes RFM +/+, isocoria, corneales +/+, OCM normal, CV responde a la amenaza bilateralmente, facie simétrica, pares bajos no evaluables

Izquierda: paresia ext superior prox M2 distal M3 (con coaching), ext inferior M3 con estímulo plantar, plantar flexor

Derecha: paresia ext superior M1 espontáneamente y M2 con estímulo nociceptivo, paresia crural M2, plantar indiferente derecho

Percibe nocicepción 4 extremidades, no impresiona asimetría

Cerebeloso: no es posible evaluar

NIHSS: 0/2/2/0/0-0/2/3/3/3-0/0/3/2/0: 24

En condiciones de traslado a hospital de base para continuar neurorehabilitación.

Diagnóstico de Egreso

Accidente vascular hemorrágico - Hematoma Lenticular Izquierdo

Fecha Epicrisis : 24/02/2023 00:22

Fecha Última Actualización: 24-02-2023 0:22:17

Página 4 de 5

Insuficiencia Renal Aguda Sobre Crónica -
Hipertensión arterial -
Demencias -

Condición de Egreso Alta Derivado al Hospital Padre Hurtado

Egreso con Catéter Doble J: NO

Vigil, no emite lenguaje (TQT), ni tiene intención comunicativa, logra seguimiento de examinador, no obedece órdenes RFM +/+, isocoria, corneales +/+, OCM normal, CV responde a la amenaza bilateralmente, facie simétrica, pares bajos no evaluables

Izquierda: paresia ext superior prox M2 distal M3 (con coaching), ext inferior M3 con estímulo plantar, plantar flexor

Derecha: paresia ext superior M1 espontáneamente y M2 con estímulo nociceptivo, paresia crural M2, plantar indiferente derecho

Percibe nocicepción 4 extremidades, no impresiona asimetría

Cerebeloso: no es posible evaluar

NIHSS: 0/2/2/0/0-0/2/3/3/3-0/0/3/2/0: 24

Plan Post Alta

GENERALES

Continuar neurorehabilitación

Mantener Alimentación por SNG, considerar GTT

Reposo: Cabecera en 30°. Movilizar cada 2 hrs (prevención lesiones por presión)

Oxigenoterapia: SOS para saturar > 92 %

Régimen: Embrace intensive 50 cc/hra

Rehabilitación: FNA. KNT.

Evaluación nutrición

HGT cada 8 hrs

Mantener invasivos: Sonda foley, LA, VVP.

FÁRMACOS

SRL 80 cc/hra IV

Cefazolina 1 gramo cada 8 horas IV (FI 18/02)

Paracetamol 1g si T ° 37.5 cada 8 hrs IV

Insulina cristalina SC si HGT > 180 mg/dl SC

HGT < 70 mg/dL indicar SG 5% (100 cc en bolo) IV

Omeprazol 40 mg/día IV

Enoxaparina 40mg al día SC

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Gino Maguida Vergara

Fecha Epicrisis : 24/02/2023 00:22

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:41

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA

Fecha Última Actualización: 24-02-2023 0:22:17

INTERNO

Becado/Residente



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Página 5 de 5

Médico Tratante (Staff)